

Tabla clínica resumida de ampollas IV QUIMICAS

Uso orientativo para adultos en entorno clínico. Las dosis IV deben individualizarse según función renal, electrolitos séricos, gasometría, ECG, vía venosa disponible y contexto clínico. El bicarbonato de sodio no se considera reposición mineral rutinaria, sino corrector ácido-base.

Nombre	Presentación	mg/mL	Tot por ampolla	Mecanismo	Dosis IV (en suero simple)	Dosis tóxica	CONTRAINDICADO	Manejo de efectos adversos / toxicidad
Sulfato de magnesio (MgSO₄)	Ampolla vidrio 10mL 20%	200 mg/mL	2000 mg (2 g)	cofactor en reacciones enzimáticas, estabiliza membrana neuromuscular	1g IV (5ml) DILUIDOS en 100ml y administrados LENTAMENTE en 20 min. NUNCA INTRAVENOSA DIRECTA RAPIDA SIN DILUIR Pasarlo solo aparte	Riesgo aumenta con insuficiencia renal. Disminución de reflejos musculares con niveles elevados; depresión respiratoria si lo pasan rápido.	No mezclar con Vitamina C / ácido ascórbico / ascorbato. No con bicarbonatos e hidróxidos, sales de calcio, salicilatos, procaínas, clindamicina, hidrocortisona.	Suspender magnesio, vigilar respiración/frecuencia cardiaca Efectos en presión y respiración moderados/severos, administrar gluconato de calcio 10% 10 mL IV lento en 5–10 min (diluir en 100ml y pasar a 10-20ml/min)
Bicarbonato de sodio (NaHCO₃)	Ampolla vidrio 10 mL 8.4%	84 mg/mL 1 mEq/mL	840 mg 10 mEq	Aporta HCO ₃ ⁻ y Na ⁺ ; amortigua pH ⁺ y corrige acidosis metabólica en indicaciones específicas.	0.5meq/kg o 0.5ml/kg. - Diluir cada 1 ml de bicarbonato en 7ml de SS0.9%. Ej: para 70 kg se cogen 35ml de bicarbonato y se deben diluir en 245ml SS0.9%. Si son mas kilos se debe diluir mas. Se pasa en 10 min o más. Pasarlo solo aparte	El riesgo es la sobrecorrección con alcalosis metabólica. NO PASAR SIN DILUIR	No mezclar con Vitamina C / ácido ascórbico / ascorbato. Edema, sobrecarga de volumen, irritabilidad, fasciculaciones, tetania; extravasación con lesión tisular.	EXTRAVASACION: detener inmediatamente infusión, dejar la cánula en sitio al inicio, aspirar la mayor cantidad posible del líquido extravasado, no hacer flush, elevar la extremidad, marcar la zona y documentarla, compresas frías y pedir valoración médica.

STOCK DE EMERGENCIA AMPOLLAS QUIMICAS

Fármaco	Mecanismo	Presentación	Dosis usual (adulto)	Cómo administrarla (paso a paso)	Cuándo repetir	Contraindicaciones / precauciones	Efectos secundarios importantes
Ketorolaco	Baja dolor e inflamación.	Ampolla 30 mg/1 mL IV/IM. También 60 mg/2 mL IM.	30 mg IV o IM.	No requiere dilución obligatoria. IV: cargar la ampolla y pasar lento. IM: aplicar profunda. La presentación 60 mg/2 mL se usa mejor IM.	Cada 6 h si hace falta. No usar más de 5 días.	Úlcera o sangrado gástrico, insuficiencia renal, alergia a AINEs (ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco), asma por AINEs, embarazo	Gastritis si es uso crónico, sangrado si usa anticoagulantes o aspirina, broncoespasmo, daño renal, mareo.
Atropina	Sube la frecuencia cardíaca y seca secreciones.	1 mg/mL ampolla inyectable.	Bradicardia sintomática: 0.5- 1 mg IV.	BRADICARDIA SEVERA: frecuencia cardíaca 50-40: No necesita dilución obligatoria. Cargar la dosis en jeringa. Pasar en bolo IV y hacer flush con salina. BRADICARDIA 60 latidos: diluir 1 ampolla en 10ml de solución salina y pasar 5ml IV	Cada 3-5 min hasta 3 mg total.	Glaucoma de ángulo cerrado, taquiarritmias, retención urinaria severa	Taquicardia, boca seca, visión borrosa, agitación, retención urinaria.
Efedrina	Sube la presión por aumento del gasto cardíaco.	Ampollas 60 mg/mL o cercanas.	6 mg IV en bolos, esperando respuesta por 2-3 min.	Sí conviene prepararla primero. Tomar 1 mL = 60 mg y completar con salina hasta 10 mL. Queda a 6 mg/mL. Dar 1 mL = 6 mg o 2 mL = 10 mg IV lento.	Repetir cada 1-2 min según presión y frecuencia cardíaca.	HTA severa, taquiarritmias, cardiopatía isquémica, hipertiroidismo.	Taquicardia, HTA, ansiedad, cefalea, arritmias.
Adrenalina (Epinefrina)	Abre bronquios, sube la presión y revierte anafilaxia / crisis de alergia severa	1 mg/mL (1:1000) ampolla o vial.	Anafilaxia (alergia SEVERA): 0.3-0.5 mg IM. Paro: 1 mg IV con protocolo adecuados.	Anafilaxia: usar sin diluir. Cargar 0.3-0.5 mL y poner IM en muslo anterolateral. No usar la ampolla 1 mg/mL en bolo IV directo fuera de paro cardíaco.	Anafilaxia: cada 5-15 min si persiste. Paro: cada 3-5 min.	En anafilaxia no hay contraindicación absoluta. Precaución en cardiopatía y arritmias.	Taquicardia, temblor, ansiedad, HTA, arritmias.
Dexametasona	Baja inflamación y alergia,	8 mg/2 mL.	4-8 mg IV o IM.	No necesita dilución obligatoria intramuscular. Puede darse IV LENTO diluida en	Según cuadro, usualment	Infección no tratada, hiperglucemia, gastritis; muchas son	Hiperglucemia, agitación, insomnio,

	inflamación de vía aérea	También presentaciones de 4 mg/mL.	Ver de que viene la presentación.	10ml o directo IM. Si prefieres, puede agregarse a pequeña cantidad de salina para pasar más cómodo.	e cada 12-24 h o dosis única inicial.	relativas en urgencia.	gastritis, HTA transitoria, picazon en ingle
Hidrocortisona	Corticoide de rescate útil crisis asmática bronquial severa , alergia severa	Vial 100 mg polvo para reconstituir.	100 mg IV o IM.	Reconstituir el vial con el diluyente del producto o con 2 mL aprox. según presentación. Una vez reconstituida, cargar la dosis. Pasar IV lento o aplicar IM.	En alergia/asma depende de evolución.	Precaución en diabetes, HTA, infección; en crisis suprarrenal el beneficio manda.	Hiperglucemia, retención de líquidos, HTA, gastritis, cambios de ánimo.
Metoclopramida	Quita náusea y ayuda a vaciar el estómago.	10 mg/2 mL.	10 mg IV o IM.	No requiere dilución obligatoria. Si va IV, pasar lento. Si prefieres, puedes completar la jeringa con salina para pasarla más despacio y cómodo.	Cada 6-8 h si hace falta.	Obstrucción intestinal, Parkinson, epilepsia, antecedente de discinesia tardía.	Somnolencia, distonía, inquietud.
Ondansetrón	Bloquea el vómito y náuseas .	4 mg/2 mL y 8 mg/4 mL.	4 mg IV o IM.	Puede darse IV lento directo. Si quieres manejo más cómodo, cargar en jeringa y completar con salina. También puede darse IM.	Cada 6-8 h si hace falta, según la causa.	Precaución en QT largo, hipokalemia, hipomagnesemia y otros fármacos que alargan QT.	Cefalea, estreñimiento, prolongación de QT.
Paracetamol IV	Baja dolor y fiebre .	10 mg/mL, usualmente 1g/ 100 mL.	1 g IV en adultos > 50 kg.	Pasar como infusión IV según presentación.	Cada 6 h. Respetar dosis máxima diaria.	Hepatopatía, alcoholismo severo, bajo peso, desnutrición.	Hipotensión durante infusión, aumento de transaminasas, hepatotoxicidad si exceso.
Gluconato de calcio	Aporta calcio y ayuda a revertir efectos del magnesio alto	10%, usualmente 10 mL = 1 g.	1 g IV	Sí conviene diluirlo. Tomar 10 mL = 1 g y diluir en 100 mL de SSN. Pasar IV lento 10-20 ml/min con vigilancia de la vena.	Puede repetirse según respuesta clínica.	Precaución si extravasa. No mezclar a ciegas con bicarbonato ni con otros fármacos incompatibles.	Irritación venosa, extravasación, bradicardia o hipotensión si pasa rápido.

Observación: las presentaciones comerciales pueden variar por marca y proveedor. Verificar siempre rotulado exacto antes de administrar.